



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



Trabajo final

Dra. Gemma Vázquez Tolentino Especialista en medicina familiar
Unidad de medicina familiar No.22
Diplomado fundamentos de la gestión directiva.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



Introducción:

Mi unidad de adscripción es la “unidad de medicina familiar No.22”, mi servicio como médico en la Unidad de Medicina Familiar es ser el eje de la Atención Primaria a la Salud y el primer punto de contacto del paciente con el sistema. Mi servicio se define por las siguientes funciones estratégicas:

1. Gestión de Primera Línea: Soy responsable de la recepción inicial y el diagnóstico de la gran mayoría de los padecimientos. Mi capacidad resolutoria en este nivel es fundamental para optimizar el flujo de pacientes y evitar la saturación de los niveles de especialidad.
2. Integralidad y Enfoque Biopsicosocial: Mi práctica no se limita a la enfermedad o al órgano; aplico un modelo de atención integral. Evalúo al paciente considerando sus esferas biológica, psicológica y social, lo que permite un diagnóstico más preciso y un tratamiento adherido a la realidad del paciente y su entorno familiar.
3. Continuidad Asistencial: Proporciono seguimiento longitudinal a los pacientes y sus familias. Esta continuidad es clave para la gestión eficaz de la salud a largo plazo, permitiendo la detección temprana de riesgos y la construcción de una sólida relación médico-paciente que mejora la adherencia terapéutica.

Misión:

La misión del IMSS es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y trabajadoras y sus familias

Visión:

Por un México con más y mejor seguridad social



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



Políticas:

Políticas de inclusión y derechos humanos

Igualdad y no discriminación:

Se trabaja para eliminar prejuicios y cambiar la cultura institucional, con políticas de inclusión y acciones para garantizar el acceso pleno a los servicios médicos y la seguridad social en igualdad de condiciones.

Derechos de las personas con discapacidad:

El IMSS busca garantizar su acceso a la salud, trabajo y capacitación, y ha implementado un decálogo institucional para atender sus necesidades de accesibilidad, movilidad y comunicación.

Derechos de parejas del mismo sexo:

Se ha ampliado el acceso a servicios de salud y beneficios de seguridad social, incluida la pensión por viudez, para concubinatos de parejas del mismo sexo.

Políticas de datos personales

Tratamiento de datos:

Se deben tratar los datos personales con base en las facultades legales del Instituto y el consentimiento del titular, y solo se deben recabar los datos estrictamente necesarios.

Confidencialidad:

Es obligación del personal del IMSS mantener la información estrictamente confidencial y no revelarla a terceros.

Transparencia:

Se debe dar a conocer el aviso de privacidad al momento de recabar datos personales y explicar la finalidad del mismo.

Políticas de salud y seguridad social

Régimen obligatorio:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



Se integra por cinco seguros: Riesgos de Trabajo, Enfermedades y Maternidad, Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y Guarderías y Prestaciones Sociales.

Conservación de derechos:

Los asegurados que dejen de cotizar conservan sus derechos a pensiones por invalidez y vida por un periodo equivalente a una cuarta parte del tiempo cotizado, contado a partir de la fecha de baja.

Atención a grupos vulnerables:

Se han establecido políticas para la atención de grupos prioritarios, como niños con cáncer, con el objetivo de aumentar la tasa de supervivencia.

Calidad:

Se busca la mejora continua en beneficio de los derechohabientes y usuarios, con políticas de calidad definidas para cada unidad.

FODA Y DAFO

Factor	Positivos	Negativos
--------	-----------	-----------



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



internos	Fortalezas 1. Personal con Experiencia: Médicos familiares, personal de enfermería y técnico con años de servicio y conocimiento del sistema. 2. Infraestructura Establecida: Se cuenta con instalaciones físicas, consultorios y áreas de apoyo (farmacia, laboratorio básico, etc.). 3. Modelo de Atención Integral: El enfoque en la medicina familiar permite un seguimiento continuo del paciente y su núcleo familiar. 4. Acceso al Sistema Nacional de Salud: Pertenencia a una institución de alcance nacional, con protocolos y guías de práctica clínica estandarizadas, así como los pases a especialidades. 5. Gran Volumen de Derechohabientes: Una base de pacientes adscritos amplia y constante, lo que garantiza la demanda del servicio.	Debilidades 1. Saturación de la consulta: Elevado número de pacientes por jornada, lo que limita el tiempo de atención por persona, además de que genera estrés excesivo en el médico. 2. Procesos Burocráticos: Excesivos trámites administrativos para referencias, incapacidades o acceso a estudios especializados. 3. Recursos Materiales Limitados: Carencia o desabasto intermitente de medicamentos, material de curación o equipo de diagnóstico. 4. Diferimiento de Citas: Tiempos de espera prolongados para conseguir una cita de seguimiento o de primera vez. 5. Falta de Capacitación Continua: Poca oferta o dificultad para acceder a cursos de actualización en temas clínicos o administrativos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
 CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



externos	Oportunidades 1. Avances Tecnológicos: Implementación de herramientas como la receta resurtible electrónica, telemedicina o expediente clínico electrónico. 2. Programas Nacionales de Salud: Campañas de prevención y vacunación impulsadas por la Secretaría de Salud que pueden ser apalancadas por la UMF. 3. Creciente Conciencia sobre la Prevención: Mayor interés de la población en temas de salud preventiva y estilos de vida saludables. 4. Convenios con Instituciones Educativas: Posibilidad de recibir estudiantes de medicina y enfermería para apoyar en tareas básicas y fomentar la formación de recursos humanos. 5. Nuevas Guías de Práctica Clínica: Actualización de la evidencia científica que permite mejorar la calidad de la atención.	Amenazas 1. Competencia de Servicios Privados: Proliferación de consultorios de bajo costo (ej. farmacias) que ofrecen atención inmediata para padecimientos agudos. 2. Recortes Presupuestales: Políticas de austeridad que pueden impactar la asignación de recursos para personal, medicamentos e infraestructura. 3. Cambios en la Legislación Sanitaria: Modificaciones en la normativa que pueden afectar los procesos de atención o administrativos. 4. Desinformación y "Dr. Google": Pacientes que llegan con información no verificada de internet, dificultando la relación médico-paciente y la adherencia al tratamiento. 5. Crisis Sanitarias o Epidemiológicas: Brotes de enfermedades (como influenza o pandemias) que saturan la capacidad de atención del primer nivel.
----------	--	--

Factores Externos / Factores Internos	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
---------------------------------------	----------------	-----------------



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



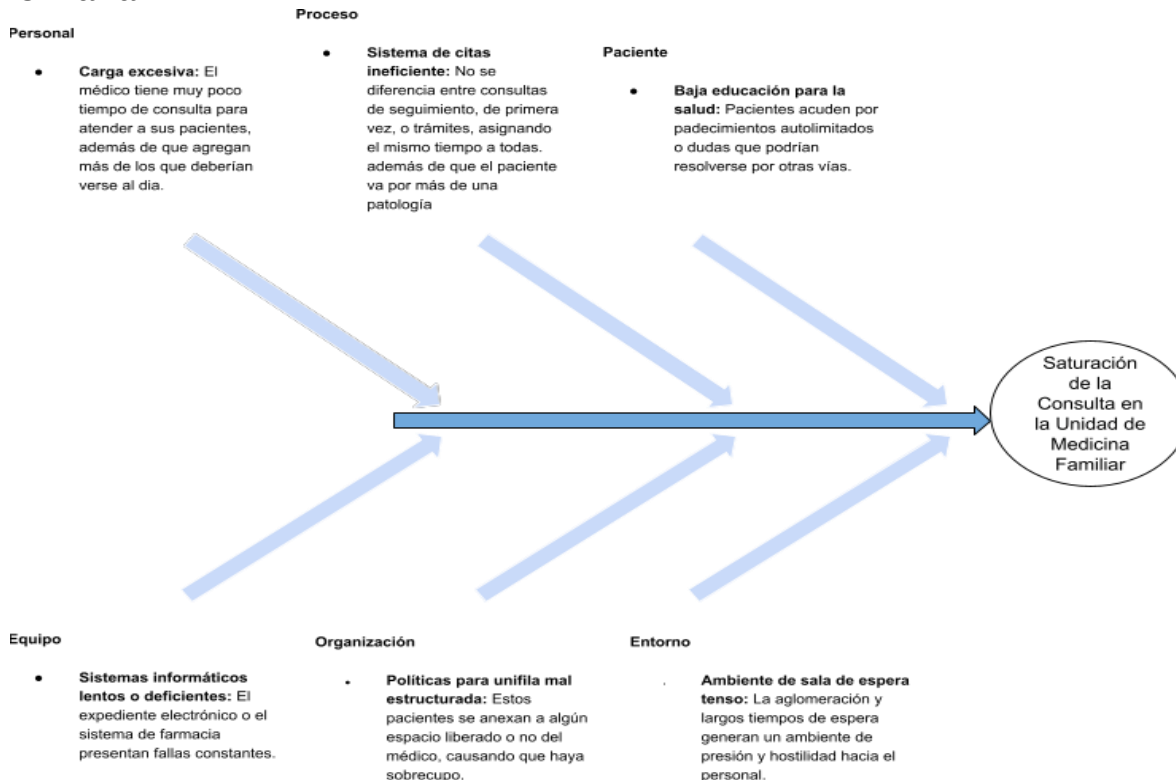
Oportunidades (O)	Estrategias FO: Utilizan las fortalezas para maximizar las oportunidades. Estrategia 1 (F1, O2, O3): Utilizar al personal médico y de enfermería experimentado (F1) para liderar jornadas intensivas de salud preventiva, aprovechando los programas nacionales (O2) y la creciente conciencia de la población (O3). Estrategia 2 (F4, O1): Apalancar los protocolos estandarizados del IMSS (F4) para implementar de manera eficiente nuevas tecnologías como el expediente clínico electrónico (O1), asegurando la unificación de la información.	Estrategias DO (De Adaptación o Reorientación) Estrategia 1 (D1, D4, O1): Implementar y promover el uso de la telemedicina y la receta resurtible electrónica (O1) para desahogar la consulta presencial (D1) y reducir los tiempos de espera para citas (D4). Estrategia 2 (D5, O4): Establecer convenios con universidades (O4) para que los pasantes apoyen en tareas administrativas y de pre-consulta, liberando tiempo para que el personal de base pueda acceder a capacitación continua (D5).
Amenazas (A)	Estrategias FA: Utilizan las fortalezas para minimizar las amenazas. Estrategia 1 (F3, A1): Reforzar y comunicar el valor del modelo de atención integral (F3) como diferenciador clave frente a la atención episódica y de bajo costo de los consultorios privados (A1), destacando el seguimiento a largo plazo. Estrategia 2 (F1, F5, A4): Usar la experiencia del personal (F1) y el gran volumen de pacientes (F5) para desarrollar campañas informativas y de educación para la salud dentro de la sala de espera, contrarrestando la desinformación de internet (A4).	Estrategias DA (De Supervivencia o Riesgo) Estrategia 1 (D1, D3, A2): Ante posibles recortes presupuestales (A2), optimizar los procesos de la consulta (D1) y la gestión de insumos (D3) mediante la implementación de un sistema de triage más eficiente en la entrada de la unidad para priorizar casos y racionalizar recursos. Estrategia 2 (D2, A5): Simplificar los procesos burocráticos internos (D2) mediante la digitalización de trámites (ej. pases a especialista) para agilizar la respuesta del sistema durante crisis sanitarias (A5) y evitar el colapso administrativo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



Ishikawa:



Plan operativo:

DELEGACIÓN:	La magdalena contreras			
UNIDAD:	Unidad de medicina familiar No.22			
PLAN OPERATIVO				
VIGENCIA DEL PLAN:	Del:	1 de noviembre de 2025	al:	
PROGRAMA O PROCESO:		SERVICIO RESPONSABLE:		
Atención medica en unidad de medicina familiar		Consulta externa		
DIAGNÓSTICO				
PRINCIPALES PROBLEMAS	Saturacion de la consulta en la unidad de Medicina Familiar			
	Tiempo insuficiente de atención medica continua			
CAUSAS RAÍZ (DE PROCESO)	Carga excesiva de trabajo en el personal medico			
	sistemas informaticos lentos o deficientes			
	Baja educación para la salud de los pacientes			
OBJETIVOS				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
 CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



ESTRATÉGICOS (DEL PLAN TÁCTICO)	Reducir la saturación de consulta
	Mejorar la calidad del servicio
ESPECÍFICOS	Disminuir el número excedente de pacientes asignados al día
	Implementar medidas para agilizar el funcionamiento de los sistemas
	Fomentar la educación para la salud de los pacientes
ACCIONES DE MEJORA	
LÍNEAS DE ACCIÓN (DEL PLAN TÁCTICO)	Reestructuración del sistema de citas.
	mantenimiento de sistemas informaticos
LÍNEAS OPERATIVAS	Clasificar las consultas de manera eficiente y eficaz
	implementar platicas y materiales educativos sobre autocuidado
	Coordinar al área de informática para mantenimiento y actualizacion.
	Realizar talleres sobre administracion del tiempo y atención eficiente.
PARÁMETROS DE MEDICIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	
META	
Porcentaje de reduccion de pacientes excedentes por jornada	
20% en 6 meses	
tiempo promedio de espera por paciente	menor a 30 min
funcionamiento óptimo del sistema informatico	90% sin fallas
participación en programas de educación para la salud	70% de pacientes
	adscritos
CONTROL	
Revision mensual de indicaciones por el jefe de servicio y elaboracion de informe trimestral con resultados ajustes y recomendaciones de mejora continua.	
NOMBRE DEL JEFE DE SERVICIO	Gemma Vazquez Tolentino

Indicador:

	Nombre: Porcentaje de reducción de pacientes excedentes por jornada
Objetivo del indicador:	Medir el grado de disminución de pacientes que exceden el número programado por jornada médica, con el fin de evaluar la



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



	efectividad de las estrategias implementadas para reducir la saturación en consulta externa	
Precisión del método de cálculo (fórmula):	Número de pacientes excedentes atendidos en la jornada actual	X 100
	Número de pacientes excedentes atendidos en la línea base	
Fuentes oficiales para el cálculo:	Numerador: número de pacientes excedentes en la jornada actual	
	Denominador: número de pacientes excedentes atendidos en la línea base	
Interpretación:	Un valor indica una mejora en la organización y eficiencia de las consultas, reflejando menor saturación y mejor gestión de citas. Un valor igual o mayor representa estancamiento o retroceso en la implementación de las acciones de mejora	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
 CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI



Valor de referencia	Promedio actual de pacientes excedentes por jornada antes de la implementación del plan (28 pacientes/día con límite de 25)		
Unidad de medida:	Porcentaje (%) — Número entero		
Periodicidad:	Mensual	Lugar y responsable:	Unidad de medicina familiar No.22 responsable Gemma Vázquez Tolentino
Rangos de desempeño	Desempeño Esperado	Desempeño Medio	Desempeño Bajo
	>20% de reducción en 6 meses	10-19% de reducción	<10% de reducción
Observaciones:	El indicador permitirá monitorear el avance de las estrategias de reestructuración del sistema de citas y mantenimiento de los sistemas informáticos. Se revisará mensualmente por la jefatura de servicio y se ajustarán las acciones conforme a los resultados.		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DOCENTE
CENTRO MÉDICO NACIONAL SXXI

